



精神疾病概述

作者: [Michael B. First](#), MD, Columbia University

Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry

已审核/已修订 10月 2024

精神健康（精神性或心理性）疾病包括思维、情感和/或行为方面的异常。生活中常会出现思维、情感或行为方面的小的波动，但当这些波动给人造成严重痛苦和/或干扰日常生活时便被称为精神疾病。精神疾病的影响可能是长期的，也可能是暂时的。

尽管在对精神疾病的理解和治疗方面已经取得巨大进步，但围绕精神疾病的耻辱感仍然存在，有时获得医疗护理的机会与一般疾病不同。例如，精神疾病患者可能会感到他们不能告诉任何人他们的症状或疾病，或感觉他们可能因为自己的疾病而受到责备。

精神疾病的原因

当前，人们认识到精神疾病是多种因素复杂交互作用的结果，涉及的因素包括：

- 遗传
- 生物（体格因素）
- 心理
- 环境因素（包括社会与文化因素）

研究表明，对于许多精神疾病，遗传因素起着一定作用。通常，精神疾病发生在那些由于遗传因素而易患此类疾病的人身上。这种易感性加上生活压力（如家庭或工作遇到困难），可能导致精神疾病的发生。

许多专家认为，一些精神疾病是因为大脑中被称为神经递质的化学物质调节异常所致。脑功能成像技术，如[磁共振成像](#) (MRI) 和[正电子发射断层摄影](#) (PET)，常显示精神疾病患者的脑部存在变化。因此，很多精神疾病似乎有生物学的成分，更像是被认为的[神经系统](#)疾病（如[阿尔茨海默病](#)）。然而，影像学检查所见的改变究竟是精神疾病的病因还是结果尚未知晓。

精神疾病的诊断

精神疾病与正常行为的界限有时并不十分清晰。例如，很难区分正常的悲伤与抑郁障碍，人们在面临重大丧失（例如伴侣或孩子的死亡）时这种区分可能非常困难，因为两者都包含悲伤和抑郁情绪。

又或者，对于因高强度的工作或个人情况感到焦虑不安、压力大的人，判断是否适合将其诊断为[焦虑障碍](#)会有些棘手，因为这是大多数人时而会有情绪。

特定人格特质（例如认真或守秩序）与[人格障碍](#)（如[强迫型人格障碍](#)）之间的区别可能很难判定。

所以，最好将精神健康与精神疾病视为一个连续的统一体。任何界限通常基于以下方面：

- 症状有多严重
- 症状持续了多长时间
- 症状对日常生活中的功能有多大影响

精神疾病的分类

美国精神病协会于1980年出版了《[精神疾病诊断和统计手册](#)》第三版(DSM-3)，标志着第一次用标准的定义和标准对精神病进行诊断的尝试。2022 年发布的最新版 DSM-5-TR 提供了一种分类系统，即尝试根据症状描述（即由病人所说的和所做的来反映其思维和感受）和病程对各种精神疾病进行诊断性分类。

世界卫生组织于 2019 年首次发布的《[国际疾病分类](#)》第 11 版 (ICD-11) 采用与 DSM-5-TR 相似的诊断性分类。这种相似性说明某些精神疾病的诊断已变得比较规范，并且在世界各国都很一致。

社会支持

每个人都需要一定的社交网络来满足被关注、被接受和感情上被支持的需求，尤其是处于压力的时候。已有研究证实，强大的社会支持可以明显促进一般疾病和精神疾病的康复。在一些社区，社会的改变减少了曾经由家庭、邻居、朋友和同事提供的传统支持。取而代之的是，许多社区都出现了自助团体和互助团体。还有许多数字来源的社会支持，如虚拟支持团体。在加入面对面或在线小组之前，患者应了解小组，以确保其合适性，确认其由具有适当资格的协调人或组织管理，并确保安全和隐私性。

有些自助小组，如匿名戒酒协会、匿名戒毒协会，聚焦在成瘾相关行为。其他一些小组则主要针对特定的人群，如糖尿病患者互助会和老年人互助会。另外的一些团体，如美国精神病联盟，还会为重病患者家属提供支持和帮助。

非住院化

自 20 世纪 50 年代以来，许多国家/地区发起了一个运动，为精神疾病患者提供护理，使他们能够在自己家而不是在机构中生活（去住院化）。这种运动能够取得成果，得益于有效的药物开发、在医学上合适的情况下尽可能在社区环境中提供精神健康治疗、各类医务人员的积极参与，以及公众对精神疾病患者的接受度变得更高。

治疗精神疾病的药物变得更加有效，因此，住院或长期住院的需求减少了。许多住院的精神疾病患者在几天内即可出院，并在日间治疗中心继续接受护理。

家庭成员也可以在社区内提供精神保健支持。已有研究显示，严重精神疾病患者和其家庭成员的某些联系能够改善或加重病情。家庭治疗技术已得到很大程度的开发，可以让家庭成员参与其中，并防止慢性精神疾病患者

需要再次住院。

不同类型的医务人员在帮助精神疾病患者重新融入社区方面发挥着重要作用。已经开发出新的治疗方法，为慢性严重精神疾病患者提供安全网，例如主动式社区治疗 (ACT)。ACT 使用由社会工作者、康复专家、心理咨询师、护士和精神科医生组成的治疗团队。该团队为患有严重精神疾病以及不能或不会去医生办公室或诊所寻求帮助的患者提供个性化服务。该服务在患者家中或附近被提供，如在附近的餐馆、公园或商店。

然而，去住院化也面临许多挑战。取代机构所提供的治疗和避免患者自己或他人受到伤害的保护需要大量的医疗资源，而并不总是有足够的资源。因此，许多人无法获得他们所需的精神健康护理以及食物、住所和其他服务支持。精神疾病患者通常缺乏获得医疗保健的机会，或容易无家可归。

当以往有严重精神疾病的人再次患病时，很难提供适当的治疗。在某些地方，法律阻止对有精神疾病但对自己或社会没有危险的人违背其意愿给予药物治疗或收治入院。尽管这些法律旨在保护人的公民权利，但却使向精神疾病患者提供所需的精神健康护理变得困难，特别是对于那些精神健康状况不佳而无法意识到自己生病或得不到治疗就会变得极度不理智的人。在医院外再次生病的人有时会变得无家可归，或被执法部门以异常行为为名而拘捕。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担任何责任。

[全国心理疾病联盟 \(NAMI\)](#)：提供宣传、教育、支持和公众意识计划和服务的国家心理健康组织。